

Krankheit	Anamnese	Status	Prozedere / Untersuchungen	Therapie	Kommentar
Kontrazeption	Partner-Anamnese, Sexualanamnese, bisherige Verhütung, Kinderwunsch, Gynäkolog. Anamnese, Zyklus-Anamnese, Fragen/Ängste, gut informieren, Zusammenfassen IRF's fragen: Rauchen, Alter, BD, BMI, Thrombosen + LE, FA, Fragen: möglichst sichere Methoden od. möglichst praktische Methode? Täglich Einnahme Pille od. lieber nicht? Mann auch einbeziehen (Kondom, Sterilisat.)? NW in Kauf nehmen?	Ev. gynakolog. Status ev. PAP Ev. Labor (BZ, Lipide, Gerinnung) PI: Pearl-Index (<0.5 s. sicher) Ö: hemmen Follikelreifung (via FSH-Suppression) G: hemmen Ovulation + Schleim + Endometrium KI: SS, CV-Erkrankungen, viele RF's, onkolog. Erkrankung, Stoffwechselprobleme Pillenwechsel: direkt nach letzter wirkstoffhaltigen Tabl. (der vorherigen Pille) mit neuer Pille beginnen, zur Sicherheit 7T. Kondome zusätzlich.	<u>Natürliche Fam-planung:</u> Fiebermessmethode, Schleimmethode, Stillen <u>Nicht-Hormonal:</u> Kondome (Rissgefahr >PI 2-12), Kupfer-Spirale (Dysmenorrhoe, Blutungen, Infekte, Perf.), Scheidendiaphragma (PI 1-20), Spermizide (PI 3-20, nur 1h wirksam), Tubenligatur (Ovarialinsuff., frühe Menop.), Sterilisat. Mann <u>Hormonal:</u> orale Kontrazeptiva/Pille (nur Gestagen mono od. Kombi mit Ö.), Vaginalring (FK, nicht immer anwendbar), Hormonpflaster, 3-Mt.-Spritze, Implanon (Stäbchen kann wandern), Gestagenspirale (Zw.blutungen) NW-Gestagene: Zwischenblutungen NW-Östrogene: prokoagulat. Zustand (Thrombosen, LE, AMI, CVI), Mamma-Ca Beide: Brustspannen, Gewichtszunahme, Ödeme, Kopf-Sz., Krämpfe, Depression, ev. Mamma-Ca, ev. Zervix-Ca (Endo-Ca↘!) Aufklärung: Zuverlässigkeit/PI, nicht-hormonale Methoden, natürliche Methoden, Einnahmemodus (21/7, 24/4 od. Lanzzeit: 1 Jahr lang, dann 7T. Pause >Blutung; bei Gestagen-Mono kein Pillenfreies Intervall), NW, Absetzen vor grösseren Ops, Vorstellung bei Sz., Kopf-Sz., Schwellung Beine od. Augen....		
Sterilität	Sex- + Zyklusanamnese, gynakolog. Anamnese, Erkrankungen Ursachen/RF: Stress, Alter, Adipositas, Nikotin, Alkohol, hormonell/Ovulationsstörung, mechanisch/Tuben/Uterus/ Adhäsionen, schlechte Spermien, Endometriose	Interstist. + gynäkolog. Status	Hormonanalytik (FSH, LH, TSH, Progesteron, PRL), vaginaler Ultraschall (Ovarien, Uterus, Tuben) Hysteroskopie (anat. Probleme) Hysterosalpingographie* Laparoskopie, Spermogramm, Immunolog. Tests (AK gg. Spermien im Ejakulat), Infekt-Screening, Psychologische Tests	Kausale Therapie, Stopp RF (Nikotin, Adipositas, Stress, etc.), mechan. Problem beheben, Infekt, etc. Hormonelle Stimulation (Clomifen, Gonadotropine FSH/LH, hCG), Insemination (Deposition Sperma in Vagina, Zervix od. Uterus) Assistierte Reproduktion/IVF	Kriterium: falls während 1-2 J. Sex ohne Verhütung keine SS. *Prüfung Durchgängigkeit
Frau mit V.a. SS / Ausbleiben der Mens	Sexual- + Zyklusanamnese, SAFT, Subj. Zeichen (Amenorrhoe, Brustspannen, Erbrechen/Nausea, Zunahme Bauchumfang...), obj. Zeichen (vergrösserte Brüste, Kindsbewegungen, Kolostrum...), Kinderwunsch, Soziales, Partner	Obj. SS-Zeichen: vergrösserte Brüste, Kolostrum, Livide Portio + Vagina, erhöhte Temp., Kindsbew. (ab 20. SSW). Spekulumuntersuchung (Lividität, Abstriche)	HCG im Urin Abstriche (bei Spekulumunters.) US (falls um 12. SSW), Dopton (Herztöne ab 6. SSW) Bestimmung Gestationsalter + Geb.termin	Ernährung, Folsäure (vor SS beginnen), RF/Süchte absetzen, Impfungen, Medikamente absetzen wenn möglich, mütterl. Krankheiten besprechen	HCG: ab 6 T. nach Konzeption Geburts termin: 1. Tag letzte Mens – 3 Mte + 7T. Gestationsalter: Scheitel-Steiß-Länge, biparietaler Durchm.
Pille danach/ Notfallkontrazeption	Sexualanamnese, Psycho, Soziales, Gesundheitliche Risiken, RF's, Fragen klären, Ängste, gut informieren			Levonorgestrel-Einmaldosis (innerhalb 72h n. Sex!) Prakt. keine NW obschon Gerinnungssystem aktiviert wird.	

SS-Abtreibung/Abbruch	Schriftlicher Antrag d. Schwangeren: Notlage, max. bis und mit 12 SSW Beratungsgespräch vor Abruptio.		Rhesus-Test (falls Mutter Rh-neg. > Anti-D-Prophylaxe vor Abort geben!)	<u>Bis 8. SSW:</u> Zervixdilatat. + Vakuumaspiration od. Medikamentös (Progesteronanalog/Mifepriston + PG-Analogen/Misoprostol) <u>9.-14. SSW:</u> Zervixdilatat. + Vakuumaspiration <u>Ab 15. SSW:</u> Medikamentös (v.a. PG's)	Risiken: Zervixverletzung falls Dilatation, Blutungen, Perforation, Infekte Auch nach 12. SSW möglich wenn schwere gesundheitliche od. seelische Gefährdung der Schwangeren.
Abort/Fehlgeburt	Fieber, AZ, Blutung (Spotting bis Massivblutung), Schmerzen, Frucht/Gewebeabgang, oft keine Symptome, SAFT, subj. SS-Zeichen erfragen RF: Nikotin, Alkohol, Trauma, Infekt, immunologisch, homonell, Anämie, Krebs, Myome, genitale Anomalien, Chr.-Störungen Fetus,	Vaginale Untersuchung sorgfältig!	SS-Test, US (Bestätigung des Aborts) Rhesus-Test (falls Mutter Rh-neg. >Anti-D-Prophylaxe vor Abort geben!) Weitere Abklärungen erst bei habituellem Abort (mind. 3 Aborte in Serie) >Chromosomenanalyse, Hormonstatus, Infekte, Immunserologien (Auto-AK), Bildgebung (Fehlbildung/Myome Uterus u.a.), Hysteroskopie	Missed Abortion: Abortkürrettage/ Absaugen A. imminens: Psychologie, Bettruhe, Mg + Progesteron ev. >Abort ev. aufhaltbar A. incipiens: Abortkürrettage/ Absaugen >Abort nicht aufhaltbar A. incompletus + completus: bei completus ist Abortkürrettage nicht nötig, bei incompletus Abortkürrettage A. febrilis: AB, Heparin , FFP	Kriterien: <500g od. <22 0/7 SSW Frühabort: bis 12 0/7 SSW, 13.– 22 SSW = Spätabort Missed A: wenig Symptome, Rückgang SS-Zeichen, ev. Schmierblutung, Frucht bleibt im Uterus, CK zu, HCG tief od. fallend Imminens: drohender Abort, leichte Blutung, ev. aufhaltbar, CK noch zu + Fetus intakt! Incipiens: beginnender Abort, starke Blutung, ev. Gewebeabgang, nicht aufhaltbar, CK offen, Uterus hart Incompletus: Blutung + Sz., nicht alles v. Frucht raus, Uterus klein, CK offen Habitueeller Abort
SS-Kontroll-Untersuchung	Schmerzen, Kindsbewegungen, Ernährung, Schlaf, Ängste, Soziales, Arbeit, Fragen	Leopold-Handgriffe (Kindslage) Gestationsalter- + Geburtstermin, ev. Geschlecht Vitalparameter (BD!)	Vitalparameter (BD >PE!) BE (Proteine, Glucose, Hämat, CRP, LK, Leberwerte, Quick) BG- + Rhesusbestimmung Serologien: Syphilis, Röteln, Hep. B, HIV, Toxoplasmose Abstriche oGTT (Ausschluss DM/Gest.-DM) U-Status (Proteinurie) US (12, 22, 32) Trisomie: Blut + US Dopton (fetale Herzöne, Freq.)	Geburtsort- + Art planen SS- + Geburtsablauf erläutern Hebamme zuteilen	
SS mit Trauma	Schmerzen, Blutung, Kindsbewegungen, AZ, Fieber, Kopf-Weh, Unfall/Tathergang, SSW, Untersuchungen, bisheriger SS-Verlauf, Krankheiten, RF's	Leopoldhandgriffe Herz, Lunge, Vaginale Untersuchung	Vitalparameter PVK + BE (HbF + Hb) Zustand Fetus überwachen: serielle US-Kontrollen, Doppler-US (Nabeschnurarternen >plazentare Situation, Doppler d. A. media cerebri	CTG: Wehen/Kontraktionen, Herzöne/Puls Fetus + Kindsbew. Baseline: durchschnittl. Puls Gefahr: Dezelerationen/Pulsabfälle (synchron mit Wehe od. nach Wehe >schlechter), Bradykardie, silent CTG (s. kleine Ausschläge, oft Hinweise Hypoxie), sinusoidales CTG (s. schlecht) Harmlos: Akzelerationen, Tachykardie (ausser wenn s. lange)	

	BERUHIGUNG		>Zentralisation, Doppler d. venöses Systems >Dekompensation erkennbar) CTG Ev. Sectio	Guter Zustand des Fetus wenn: Puls 90-150, saltatorisches CTG (grosse Zacken/Amplituden, wenig Dezelerationen, keine Bradykardie). Berechnung der Kurzzeitvariabilität >falls Kurz Azidose des Fetus!	
SS mit VBS	Menge, Farbe (Klar? Blutig?), Fieber, Infektzeichen erfragen, Schmerzen, Kindsbewegungen, AZ, SSW, bisheriger SS-Verlauf, Krankheiten, RF's	Vitalparameter Leopoldhandgriffe Vaginale Untersuchung (Bishop-Score) Herz, Lunge	1. Hospitalisation: PVK + BE, AB, Abstriche, US 2. 24h Abwarten , falls keine Wehen > Einleitung Geburt (ausser noch zu früh >abwarten, Tokolyse)		Exkurs Medis in SS: Paracetamol, Pethidin, PDA, Penicillin
SS mit Präeklampsie	SAFT, PE in vorheriger SS, PE in Familie, Schmerzen, Ödeme, neurolog. Probleme Schwere PE: Bauch-Sz., Kopf-Sz., Doppeltsehen, Augenflimmern, Dyspnoe, Hyperreflexie		Vitalparameter >BD-Messung! BE (Th's, Leberwerte, Quick, Hämatokrit, LDH, Hb, Niere) 24h-Urin *Mg-Spiegel intensiv überwachen: Blutspiegel, Reflexe (falls zu viel Mg Areflexie), Atmung (macht Atemdepression),	1. Hospitalisation oft 2. Engmaschige Kontrollen Mutter (Parameter + Symptome) + Fetus (CTG, US) 3. Medikamente: Metoprolol od. Nifedipin (nur falls >160/110mmHg!), *Mg i.v. (bei schwerer PE, wird antikonvulsiv) 4. Geburtseinleitung: ABER Abwägen Risiko f. Kind (FG) und Risiko Mutter (durch PE)	Kriterien: >140/90 + Proteinurie >3g/24h Schwere PE: >5g Proteinurie od. >160/110 mmHg, ZNS-Störungen, L-Ödem, etc. HELLP: Hämolyse, erhöhte Leberwerte, Th-Penie, auch postpartum möglich, typisch Oberbauch-Sz. Eklampsie: Epi-Anfälle, Th: Mg Atypische PE: isolierte Proteinurie
Gestationsdiabetes	Vorbestehender DM od. erst in SS, FA, Durst, Polyurie, Ernährungsverhalten, oGTT gemacht? Gestations-DM wird i.d.R. i.R. v. Screening bemerkt in SS.	BZ-Messung , falls pathologisch > oGTT (zw. 24-28. SSW) BE (Kreatinin, Glucose, HbA1c)	1. BZ-Kontrollen 2. Diäteeinstellung, Insulin falls nötig 3. Überwachung Fetus via US (Wachstum, Fruchtw.menge) + CTG 4. Bei Makrosomie vor Termin entbinden od. Sectio 5. Fetus postpartal überwachen + Glucose geben		Kriterien: nicht vorbestehend (falls erst nach 22. SSW wohl nicht vorbestehend) Folgen: RF f. Präeklampsie + Infekte, Makrosomie, FG, Polyhydramnie, Plazentainsuff., etc.
Hochschwangere mit Wehen	Siehe CST	Messungen: Vitalzeichen, Gewicht, Grösse, Temperatur Status: Kardio, Lunge, Neuro, Nierenlogen, Psyche, LK, SD, Ödeme, Varizen Leopoldhandgriffe Vaginale digitale Unters. (Bishop-Score, immer wieder messen)	PVK + BE US (Lage, Stellung, Haltung Kind, Plazenta) CTG (Monitoring Fetus + Wehen Mutter)	1. Analgesie (Opiate, PDA) 2. Spontangeburt od. 3. Einleitung: Falls vaginale Entbindung und Frau am Termin od. Übertragung und Wehen nicht stark genug > Blasensprung machen + PG's (Misoprostol, macht MM weich), und/oder Oxytocin (Syntocinon, macht Wehen, erst geben wenn MM offen)	Entbindung: Sectio od. Vaginal Bishop-Score: Kopfstand, VHL/HHL, MM-Öffnung wie stark, Cervix wie fest verkürzt, Portiologie, etc.

Schwangere mit Blutungen	Abort: schwach bis starke Blutung, meist erste 2 Trimenon EUG: s. unten Zeichnungsblutung: bei Geburt Vorz. Pl.lösung: 2. SS-Hälfte, Blutung, Sz., Kontraktionen, bretttharter Uterus, ev. Schock Pl. Prävia: 2. SS-Hälfte, sz.-lose Blutung, sonst wenig Symp. Uterusuptur: 2. SS-Hälfte, starke Blutung + Sz., Kontraktionen, oft Schock	Vaginale Untersuchungen i.d.R. KI Vitalparameter PVK + Volumen (ev. EC's) Testblut + Labor (Blutbild, CRP, Quick, Leberwerte, Fibrinogen) US CTG	Hämodyn. Stabilisierung + jee nach Ursache: <u>Abort:</u> Curettage /Absaugen (ausser wenn komplett) <u>EUG:</u> <u>Zeichnungsblutung:</u> nichts <u>Uterusruptur:</u> sofort Laparotomie (Stillung Blutung) <u>Rest</u> (auch Uterusruptur falls erst drohend + noch n. erfolgt): meist Notfall-Section Falls <34 SSW od. nicht so akutes Bild > konservative Th.: engmaschicke Kontrollen Mutter + Kind (CTG), Infusion, ev. EC's, Fe, Bettruhe, Tokolyse (um Uterus ruhigzustellen), Lungenreife, Anti-D- bei falls Rh-Neg., oft US + CTG		DD: Abort: imminens od. incipiens Zeichnungsblutung: bei Geburt, schwach + mit Schleim vermischt. Vorzeitige Pl.lösung: Pl. Prävia Uterusruptur Insertio velamentosa
Endometriose	Zyklus-Anamnese (oft Hypermenorrhoe + Metrorrhagie), Gynäkolog. Anamnese, Dysmenorrhoe, sonstige Schmerzen (oft zyklusabh., diffus in Abdominalhöhle v.a., chron.-rezidiv., li. oft mehr), Dyspareunie, unerfüllter Kinderwunsch, Defäkationsbeschwerden, Dysurie, bei Amenorrhoe (SS z.B.) + zw. Zyklen beschwerdefrei, Infertilität? Blut in Urin/Stuhl/ Mens	Untersuchung Abdomen Gynäkolog. Status: Inspektion Vulva/Vagina, Spekulumuntersuchung (genaue Inspektion Portio), bimanuelle Palpation (Tastbefund ev.) Lymphknoten Herz-Lunge	US Laparoskopie mit Biopsien Ev. Rectoskopie Labor sinnlos	1. Abwarten (wenn Zufallsbefund und keine Symptome) 2. NSAR, Ovulationshemmer (gestagenbetont) 3. GnRH-Analoga 4. Ops (Exzision, Laserovaporisation)	Selten maligne Entartung (gemäss Folien entartet es nicht, aber Risiko f. Ovar-Ca). GnRH-Analoga: neg. Feedback d. FSH/LH-Prod. >Stimulus d. Endometriose entfällt.NW!
Uterusmyom	Chron. Blutungsstörungen (Zwischen- od. Dauerblutungen, Hypermenorrhoe), chron. Schmerzen (Dehnungs- od. Druck-sz.), Dysmenorrhoe, Krämpfe, z.T. akutes Abdomen, ev. Fertilitätsprobleme, z.T. symptomlos	Abdomen Gynäkolog. Status	Vaginaler US Hysteroskopie Selten CT od. Laparoskopie	1. Medis: Lanzeitgestagene p.o. od. intrauterine Gestagenspirale, GnRH-Analoga 2. Myoenukleation od. – embolisation 3. ev. Hysterektomie	Th. nur wenn sympt. Myome od. grosse schnell-wachsende Myome od. Infertilität. Höchst selten Entartung. Medi-Th: Blutungen + Wachstum d. Myome wird gehemmt.
Vaginale Blutung	<u>Blutungs-Anamnese</u> (plötzlich od. chron., Menge) <u>Zyklus-Anamnese, Gynäkolog. Anamnese</u> (SS, Dysmenorrhoe, Dyspareunie, Blutung, Fluor, Juckreiz, FK-Gefühl), <u>Begleitzeichen</u> (Fieber, Nausea/Emesis, AZ, Müdigkeit, B-Symptome), <u>Sex-Anamnese</u> (Verhütung, Sex, STD), <u>Unmöglichkeit Schwanger</u> zu werden, Blut in Stuhl od. Urin,	Abdomen Gynäkolog. Status LK	SS-Test! Labor (Hb, B-HCG, CRP, LK, Gerinnung, ev. Tumormarker) U-Status US (transvaginal meist) Hysteroscopie + ev. Biopsie Laparoskopie im Zweifel CT/MRI	PMPB/RF/dicke EM: Hysteroskopie + Biopsie >falls Ca Th. je nach Ca/Staging , sonst Curettage (Blutungsstopp), ev. HRT Rest siehe oben/unten	DD: Endometriose (s.unten) Zyklusstörungen (s. unten) Abort (Kurettage, s. oben) EUG (s. unten) Myome/Polypen RF/verdicktes Endometrium/PMPB (nach Menopause an Endometrium-Ca denken!) PMPB: postmenopausale Blutung

Unterbauch-Schmerzen	Schmerz-Anamnese (plötzlich od. chron., bds., Ausstrahlung, Sz. beim Gehen, nachts, nach plötzl. Bewegung), <u>Zyklus-Anamnese</u> , <u>Gynäkolog. Anamnese</u> (SS, Dysmenorrhoe, Dyspareunie, Blutung, Fluor, Juckreiz, FK-Gefühl), <u>Begleitzeichen</u> (Fieber, Nausea/Emesis, AZ, Müdigkeit, B-Symptome), <u>Sex-Anamnese</u> (Verhütung, Sex, STD), <u>Unmöglichkeit Schwanger</u> zu werden, <u>Blut in Stuhl od. Urin...</u>	Abdomen (Auskultation, Palpation: 4 Quadranten, Loslass-Sz. (gekreuzt), Append.-Punkte) Gynäkolog. Status LK Exkurs: Ovarialzyste/Ruptur Sz. bei Ruptur, rupturiert spontan, bei Sex od. bei bimanueller Untersuchung, akutes Abdomen/Sz., ev. Blutung (ins Abdomen) >Laparoskopie. Hämorrhagisches Corpus luteum kann genau gleiche Symptomatik machen.	SS-Test Labor (BB, B-HCG, CRP, LK, ev. Tumormarker) U-Status US (transvaginal Transvaginaler US Hysteroskopie Laparoskopie im Zweifel CT, MRI Ev. Abstriche	Fehlbildungen: Operative Korrektur Zysten: Laparoskop. Th. od. Watchfull waiting Ovulations-Sz/Hämorrhagisches C. luteum: Pille geben (Unterdrückung Eisprünge), falls s. starke Symptomatik Laparoskopie mit Koagulation od. Naht des blutenden Follikels Adnexitis: AB, Analgesie , ev. Laparoskop. Abszess-Drainage	DD: Ovulations-Sz./häorrhag. C.I. Dysmenorrhoe (sz.hafte Mens bei Hormoninbalance, s. oben)) Anatomische Malformationen Myome (Sz. + ev. Blutung) Endometriose (s. unten) EUG (s. unten) Zystenruptur (Sz.) Ovartorsion (plötzl. starke Sz.) Adnexitis (Keimaszension, Sz. + Fieber, oft bds.!) Anderes (GIT: Divertikel, Append.)
EUG	<u>Unterbauch-Sz.</u> (wechselnd intensiver dumpfer Spannungs-Sz., ev. Sz-freie Intervalle, ev. Ausstrahlung in Rücken + Schulter, falls Tubaruptur plötzlicher starker Sz.), <u>Amenorrhoe</u> , <u>positiver SS-Test</u> , <u>Schmierblutung/Spotting</u> od. starke Dauerblutung, subj. SS-Zeichen oft nur gering (Nausea, Erbrechen, Brustspannen...) RF: Sterilitätsbehandlung, frühere EUG, Operationen, St. n. Infekt, Rauchen, IUD		<u>Status</u> Abdomen (Peritonismus ev., ev. Druck-Sz., Loslass-Sz. ev.) Spekulumuntersuchung (brauner Ausfluss aus Zervixkanal), bimanuelle Untersuchung (Druck-Dolenz im Adnexe-bereich, Portioschiebe-Sz., ev. Resistenz)	<u>Prozedere/Dx</u> Vitalparameter, PVK Labor (B-HCG , Kreatin-Kinase, Progesteron) Abd. + vaginaler US (Ausschluss SS im Cavum uteri, nicht einfach) Ev. Laparoskopie (falls B-HCG hoch, US aber nicht klar)	<u>Therapie</u> Initial ev. Medi: Methothrexat (z.T. KI! P.o. selten, ev. i.m.) Laparoskopie (2/3 d. Fälle) > Salpingotomie, selten Salpingektomie Oft in 6.-8. SSW
Ovartorsion	Meist plötzlicher starker scharfer einseitiger Abdominal-Sz., oft nachts auftreten, kollikartig, zeitweise voll Sz-frei, Fieber, Nausea/Ebrechen, Bewegung als Auslöser?	Abdomen (Loslass-Sz., Defense) Gynäkolog. Status (Tumor palpabel, Sz-Hafte Adnexe-region)	Vitalparameter PAVK (Analgesie), BE Doppler-US (Blutfluss zum Ovar, oft schwierig), Laparoskopie, U-Status	Laparoskopie (Detorquierung + Ovaropexie, falls Infarzierung Ektomie)	DD: EUG, Salpingitis, Abort, Ovarialzyte, nekrot. Myom, Appendizitis, Pyelonephritis, Zystitis, Nephrolithiasis
Zyklusbeschwerden/ Blutungen	Mens zu stark od. zu schwach (Hypomenorrhoe, Hypermenorrhoe, Menorrhagie, Metrorrhagie, Menometrorrhagie), Zklus zu lang od. zu kurz (Poly-, Oligo- od. Amenorrhoe, Zyklus-Anmanese, gynäkolog. Anmanese	Gnyäkolog. Status Labor (Hb, Hämatokrit, Fe, US Biopsie ENdometrium (falls rezidiv. Metrorrhagien od. Menometrorrhagien>Endometrium-Ca)	<u>Therapie</u> Gestagene, Ovulationshemmer Falls nicht erfolgreich od. zu starke Blutung: ev. operative Sanierung (Endometriumablation via Laser/Koagulation, ev. sogar Hysterektomie), i.d.R. aber	Hypomenorrhoe: schwache kurze Mens, bei Konstitution/Atrophie Hypermenorrhoe: starke lange Mens, bei Myomen/Endometriose /Polypen Menorrhagie: falls Mens 7-14 T. Metrorrhagie: Zwischenblutungen Menometrorrhagie: falls Metrorrhagie >14T. dauert, oft Adoleszenz + Perimenopause Tumor Polymenorrhoe: wenn Zyklus <25 T., meist weil harmlose Lutealinsuffizienz Oligomenorrhoe: wenn >35 T., Abklärungen wie bei Amenorrhoe Amenorrhoe: falls Zyklus >90T.	
Amenorrhoe	Zyklus-Anamnese, Gynäkolog. Anamnese, Entwicklung Trigger: Medis, Stress, Ernährung, Chemo, RT, SS	Internist. Status, Gewicht Gynäkolog. Status (Androgenisierungszeichen) Tannerstadien (bei Jugendlichen)	Labor (SS-Ausschluss: HCG) Hormonstatus (FSH, PRL, TSH, Testosteron, Estradiol) Gestagentest (Gabe v. Gestagenen 10 T., nach Stopp kommts nur zur Blutung wenn genügend Ö. vorliegen)	1. Therapie Grundkrankheit 2. Östrogen-Gestagen- Behandlung (falls zu wenig Östrogene) 3. Gestagenbehandlung (falls genügend Östrogene, Gestagen-Test positiv)	Primäre A.: falls Menarche nach 16j. nicht eingetroffen, ev. Gonadale Störungen (Turner-Sy/Gonadendysgenesie/Androgen-Insensitivitäts-Sy), hypothal.-hypophys. Störungen (Kallman-Sy), uterine Störungen , extragenitale Störungen (Hypothyreose)

			Vaginaler US	4. Falls Kinderwunsch Follikelreifung via FSH od. Clomifen	Sekundäre A: SS, ovariale Störungen (PCOS), Klimakterium präcox (vor vor 40), Hypothal.-Hypophys.-Störung, Hyper-PRL, Anorexie, Extremsport
Zervix-Dysplasie	Meist asymptomatisch, Sexual-Anamnese + gynäkolog. Anamnese RF: Rauchen, Vit-Mangel, Immunschwäche, orale Kontrazeptiom	Spekulumuntersuchung (z.T. sieht man CIN als Blick-Dx in Transformationszone)	PAP-Abstrich /Zytologie Essigsäure Biopsie (falls Verdächtiger Essigsäuretest od. v. Auge sichtbar)	Prophylaxe: HPV-Impfung (11-14-jährige od. vor ersten sex. Aktivität >15-19-jährige auch Empfohlen da mittleres Alter beim 1. Mal 18J. ist.) Therapie CIN: I >lokale Destruktion (Laser, Kryo...), II-III >Exzision/ Konisation + Zervixkürettage	HPV-Impfung: 6, 11, 16, 18, max. bis 26-jährig kann man s. impfen.
Dyspareunie	Sexualanamnese, Gynäkolog. Anamnese	Gynäkolog. Status	Ev. Hormonstatus	Gleitgel, Cremen, ev. Hormontherapie	
Wechseljahres-Beschwerden	Dyspareunie, Schlafprobleme, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Depression, Kopf-Sz., Wallungen, Schweissausbrüche, Libidoverlust, Trockene Schleimhäute, Tachykardie, Panik, Energielos, etc.	Internist. Status (Herz, Lunge, Abdomen, Haut, Schleimhäute, Neuro) Gynäkolog. Status	NW HRT: Gewichtszunahme, CV-RF, hormonabh. Tumoren werden gefördert (Mamma-Ca)	HRT (H-Ersatztherapie: Östrogene, Gestagene, Androgene, Tibolone, Anti-Androgene, Anti-Östrogene) Nicht-Hormonale Methoden (Pflanzenextrakte, SSRI, Akupunktur, autogenes Training)	Kriterium: 12 Mte. lang sek. Amenorrhoe, i.d.R. zw. 40-56 Tibolone: Pro-Drug, hats gestagene, östrogene + androgene Komponenten NW d. Menopause: Osteoporose, CV-Risiken (Lipidprofil ändert s. + Gefässwände), Alzheimer,
Inkontinenz	Belastungsinkontinenz: Unwillkürlicher Urinabgang bei Belastung, Niesen, Husten, RF: SS, Geburten, Alter, Rauchen, Adipositas Hyperaktive Blase: Unwillkürlicher Urinabgang weil Detrusorkontr., erhöhte Miktionsfreq., Nykturie, Pollakisurie, Harndrang + kann es nicht verheben Mischinkontinenz: Kombi v. Symptomen	Vaginaluntersuchung: Senkungen, Trohik, Zelen, Sekret, etc. Hustentest mit gefüllter Blase (Urinabgang?), wie stark Beckenboden trainiert? Trigger: Multipara, Obstr. Lungenerkrankungen, Adipositas, Menopause, Genetik	Miktionskalender (Freq., Menge, Auslöser), BE (DM) U-Status (Infektausschluss) Restharnbestimmung (US) Messung Blasenwanddicke Beckenboden-Untersuchung Perineal- + Introitus-US , ev. Urethro-Zysto-Skopie , Urodynamik (Urethradruckmessung, Zystometrie) Obejektivierung/Quantifizierung Urinverlust (Windeln wiegen)	Überaktive Blase: v.a. Medis Miktionsverhalten ändern/ Blasentraining , Medis (Anticholinergika, Botulinum -Inj.), Psychologie Belastungsinkontinenz: v.a. Ops Beckenbodentraining, Pessare, Ops (Schlingen od. Suspension), ev. Medis (SNRI, Östrogen) Beide: Gewichtsreduktion, Rauchstopp, Regul. Verdauung	Belastungsinkontinenz (Stressink.) Überaktive Blase (Drangink.) Messung Blasenwanddicke (DD ob Belastungsinkot. od. hyperakt. Blase >5mm = hyperaktive Blase)
Vaginaler Infekt	Sex-Anamnese (wann, was genau, Verhütung, Partner/in, Reisen), Symptome (Fluor>Farbe/Geruch/Menge, Juckreiz, Sz., Rötung, Geruch, Spotting, Dysurie, Gelenke, Augen,	Gynakolog. Status: Inspektion (Rötung, Schwellung, Fluor, Bläschen, Ulzera, Kruste, Beläge), Vulva, Vagina + Portio (Spekulum), Portioschiebe-Sz. Abdomen	Nativ-Präparat (Vagina), Färb-Präparate (Pilze u.a.), Gardnerellen-Präparat, Abstriche (Chlamydien, Gonorrhoe), Syphilis-Schnelltest od. Serologie, pH-Messung	Chlamydien (Doxycylin), Gonorrhoe (Ceftriaxon), Syphilis (Penicillin): AB Bakt. Vaginos: Metronidazol Tr. vaginalis: Metronidazol Pilz: top. Antimykotika (Creme)	DD Chlamydien (Abstrich) Gonorrhoe (Abstrich) Lues/Syphilis (Schnelltest od. Serolog.) Bakterielle Vaginose/Gardnerellen (Amin-Präparat) Trichomons vaginalis: Nativ-Präparat

	Mund)	Lymphknoten Internist. Status: Haut (Effloreszenzen), Konjunktivitis, Arthritis, Lyphadenopathie		H. genitalis: Aciclovir, Analgesie <u>Condylomen:</u> Aldara, Laser, Kryo	Pilz (Nativ- od. Färb-Präparat) H. genitalis (Blick-Dx. od. Abstrich) Condyloma (Blick-Dx. od. Biopsie, falls an Cervix PAP +/-od. Essigsäure), etc.
HWI	Zystitis: Fieber, Sz./Brennen beim Wasserlösen, häufiges Wasserlösen, Harndrang, Urin- Farbe, Blut, Menge, Trübung, Trinken, AZ, Intimpflege, Trinkverhalten, Opstipation Darm, wie oft Pinkeln Pyelonephritis: zusätzlich Fieber, Nieren-Sz., red. AZ Trigger: Sex, St. n. HWI, + FA, Tampons + Kondome, AB, Alter	Vaginal-Untersuchung nur nötig wenn rezidiv. HIW od. komplizierter HWI: Vaginalinspektion, Abstrich (inkl. Urethra) Nierenlogien!	Comboor-Streifentest reicht meist (LK, Nitrit), aber U-Status (mit Sediment: LC, EC, Bakterien) + Urikult oft auch gemacht US (nur wenn rezidiv., pers. od. komplizierter HWI >Restharn) MCUG (Reflux), CT, selten	1. Viel Trinken (Cranberrysaft, Bärentraubenblätterttee) 2. AB (3. Tage Ciprofloxacin z.B.), Spasmolyticum/falls kompliziert mind. 10 T. (und möglichst resistenzgerecht/Kultur) 3. Kontrolle falls nach 3 T. keine Besserung Pyelonephritis: zusätzlich Bettruhe, ev. Hospitalisation	Meist E. Coli
Knoten in der Brust	Tastbarer Knoten, Einziehung, Mamillensekretion, Peau- D'orange, Rötung, Schmerzen, axilläre LK, Skelett-Sz., B- Symptome, AZ, Müdigkeit RF: HRT, + FA, Alter, St. n. Mamma-Ca, Adipositas, Alk,	Untersuchung der Brust (s. CST) LK (Hals + Axillär)	US Mammographie MRI (bei Jungen) Biopsie , ev. FNP/Biopsie LK Staging (bei kl. Tumoren nicht): CT/PET oder: BE, Mammographie Gegenseite, SLK, Rx-Thorax, Szinthigraphie, Oberbauch-US	Je nach Ca-Typ/Grösse, Grading, Alter, Hormontatus, Staging, etc. >individuelle Th. <u>Falls operabler Tumor od.</u> <u>lokoregionäres Rezidiv und keine</u> <u>Metastasen</u> Ops (Mamma-erhaltend od. Ablatio), ev. Lymphonodektomie , ev. neo- + adj. Chemo, ev. Hormonth. (Tamoxifen /Ö-R-Ant. + ev. Aromatase-Hemmer <u>Falls Metastasen:</u> palliativ	

SS-Test nie falsch! Zur Sicherheit immer machen zu Beginn der Diagnostik!